

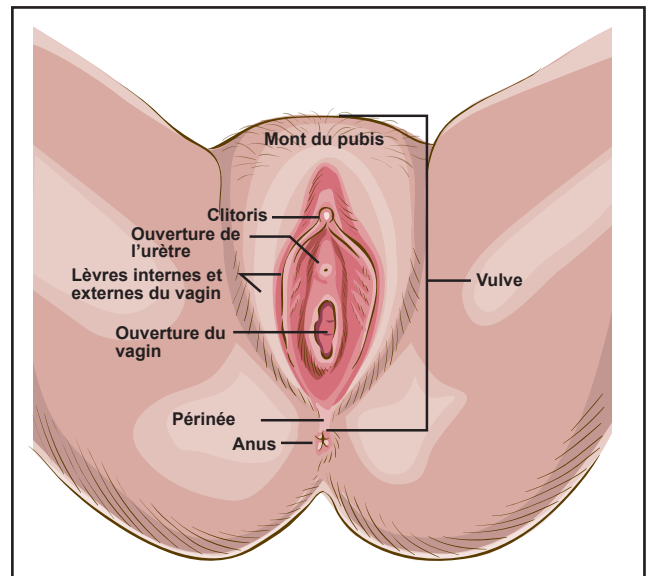
Vulvodynie

Qu'est-ce que la vulvodynie?

La vulvodynie désigne une douleur de la vulve qui n'est pas associée à un problème cutané ou nerveux, en l'absence d'infection. La vulve est la peau externe du vagin; elle comprend l'ouverture du vagin, les lèvres (lèvres internes et externes), le clitoris, l'ouverture de la vessie (urètre) et le mont du pubis. La douleur peut durer de trois mois à plusieurs années. Elle s'arrête parfois spontanément. La vulvodynie ne se transmet pas entre partenaires; elle n'est pas liée au cancer.

Quels sont les symptômes de la vulvodynie?

La vulvodynie se traduit par une sensation de brûlure, des picotements, des douleurs et un endolorissement de la vulve (en général, les démangeaisons ne sont pas un signe de la maladie). Cette douleur peut être constante ou apparaître au toucher (p. ex., durant les relations sexuelles, les préliminaires ou l'utilisation d'un tampon). La sensation de douleur peut varier, allant d'une sensation légèrement inconfortable à une douleur très intense, ce qui peut empêcher la personne de s'asseoir confortablement ou perturber son sommeil. La vulvodynie peut être très douloureuse certaines journées, et pas du tout d'autres journées.



Quelles sont les causes de la vulvodynie?

Selon les experts, les causes peuvent être multiples. Par exemple, il peut s'agir d'une hypersensibilité à la douleur des terminaisons nerveuses de la vulve et/ou d'une hyperactivité des muscles pelviens. Bien que la vulvodynie puisse causer beaucoup de souffrance émotionnelle, rien ne prouve qu'il s'agit principalement d'une affection psychologique. En général, votre prestataire de soins primaires ne peut constater de motif visible de cette affection et les résultats de tout test de dépistage d'une infection ou d'autres affections sont normaux. Il est important de savoir que de tels résultats n'indiquent pas que tout va bien.

Comment la vulvodynie est-elle traitée?

La meilleure façon de prendre en charge l'hypersensibilité des fibres nerveuses consiste à administrer des traitements qui modifient la manière dont l'organisme réagit à la douleur. **Veillez noter que les analgésiques et narcotiques habituels ne soulagent pas** les symptômes de la vulvodynie.

- Un gel anesthésique local ou de la lidocaïne (à 5 %) en gel ou en crème pourraient soulager les symptômes et être efficaces durant les relations sexuelles.
- La physiothérapie peut contribuer à soulager les spasmes des muscles des cuisses et des autres muscles de la région.
- Certains dispositifs (tels qu'un coussin en forme de beignet) peuvent rendre la position assise plus confortable, et éviter à la patiente de s'asseoir sur la zone douloureuse.
- L'acupuncture, notamment lorsque la douleur est constante, peut soulager les symptômes en « désactivant » les fibres nerveuses nociceptives hyperactives.
- Les psychothérapies peuvent aider la patiente à faire face à cette situation. Le *counselling* sexuel, individuel ou en couple peut aussi aider.
- Dans l'ensemble, bien que les médicaments aient un rôle limité dans le traitement, votre professionnel de la santé peut discuter de ces options avec vous.

© La Fondation pour l'éducation médicale continue, www.fmpe.org

Novembre 2017